

COURS MAGISTRAL : SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT – THÉORIES ÉCONOMIQUES, ENJEUX BIOPOLITIQUES ET PERSPECTIVES AFRICAINES

INTRODUCTION

Dans le champ de l'économie du développement, de la sociologie de la santé et de l'analyse des politiques publiques, le couple conceptuel « Santé et Développement » forme une alliance dialectique fondamentale. La santé ne se résume plus, selon la définition classique de l'Organisation mondiale de la Santé, à une simple absence de maladie ou d'infirmité. Elle est désormais appréhendée comme un état complet de bien-être physique, mental et social, constituant à la fois un droit humain inaliénable et un capital corporel indispensable. Le développement, quant à lui, a profondément évolué sous l'impulsion des travaux fondateurs de l'économiste Amartya Sen. Il a dépassé le strict indicateur de la croissance du Produit Intérieur Brut pour englober le concept de développement humain, défini comme le processus d'élargissement des libertés réelles et des capacités des individus, c'est-à-dire leur capacité à choisir et à mener des modes de vie qu'ils ont des raisons légitimes de valoriser.

Problématiser le rapport entre santé et développement à un niveau Master exige de dépasser la vision linéaire et unidirectionnelle qui ferait de la santé une simple conséquence mécanique de l'enrichissement économique. Il s'agit au contraire d'analyser la santé comme une infrastructure causale du développement, c'est-à-dire un investissement productif majeur qui détermine la productivité du travail, la formation du capital humain, la transition démographique et la trajectoire de croissance à long terme des nations. La tension centrale réside dès lors dans l'allocation des ressources publiques au sein des pays du Sud, confrontés au dilemme de financer des systèmes de santé résilients face aux urgences sanitaires globales tout en gérant de lourdes contraintes budgétaires structurelles.

L'ancrage théorique de cette relation s'est structuré autour de plusieurs vagues de paradigmes scientifiques distincts. Durant les décennies 1950 et 1960, dominées par les théories de la modernisation et de la croissance linéaire, les dépenses de santé étaient perçues par les institutions financières internationales comme des coûts de consommation sociale non productifs, devant être différés jusqu'à ce que l'industrialisation lourde soit achevée. Le grand tournant épistémologique s'opère dans les années 1980 avec l'émergence des théories de la croissance endogène, portées par des économistes tels que Robert Lucas et Paul Romer, qui intègrent le capital humain comme principal moteur du progrès technique. La santé, au même titre que l'éducation, passe du statut de charge budgétaire à celui de facteur de production accumulable, améliorant la qualité intrinsèque de la force de travail. En 1993, le rapport de la Banque mondiale intitulé *Investir dans la santé* consacre cette approche macroéconomique, démontrant le retour sur investissement massif des interventions sanitaires de base.

En Afrique, et singulièrement au Sénégal, cette dynamique s'inscrit dans une historicité marquée par les ruptures. Après l'époque coloniale caractérisée par une médecine militaire tropicale centrée sur la préservation de la main-d'œuvre des comptoirs et des cultures de rente, les indépendances ont tenté de bâtir des systèmes de santé nationaux universalistes. Cependant, la crise de la dette des années 1980 et l'imposition des Programmes d'Ajustement Structurel ont brisé cet élan. Les coupes

sombres dans les budgets sociaux et l'instauration de l'initiative de Bamako en 1987, basée sur le recouvrement des coûts par la participation financière directe des malades, ont entraîné une précarisation de l'accès aux soins et un transfert de la charge financière sur les ménages les plus pauvres, gelant pendant deux décennies les indicateurs de développement humain.

Sur le plan académique, l'étude de la santé et du développement se situe à la croisée de la macroéconomie, de la démographie, de l'épidémiologie et de l'anthropologie politique. Elle permet de modéliser les trappes à pauvreté, d'analyser les transitions épidémiologiques et de comprendre comment les déterminants sociaux, à l'instar de l'accès à l'eau potable, de l'éducation des filles et de la salubrité environnementale, surdéterminent l'état sanitaire d'une population. Les enjeux contemporains de cette recherche sont denses et interconnectés. Il y a d'abord le défi de la transition épidémiologique double. Les pays en développement font face au fardeau persistant des maladies infectieuses, comme le paludisme, la tuberculose et le VIH, tout en subissant l'explosion des maladies non transmissibles, telles que le diabète, les cancers et les maladies cardiovasculaires, en raison des mutations des modes de vie et de l'urbanisation rapide. Vient ensuite l'impératif de sécurité sanitaire mondiale et de santé globale. La multiplication des crises zoonotiques majeures, de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest à la pandémie de Covid-19, démontre que la santé est un bien public mondial dont la fragilité dans une région peut paralyser l'économie planétaire. Enfin, le déploiement opérationnel du concept « Une seule santé » ou One Health s'impose académiquement pour analyser les interdépendances strictes entre la santé humaine, la santé animale et l'intégrité des écosystèmes face aux changements climatiques.

Pour les décideurs politiques et les planificateurs, la santé est le socle de l'efficacité de toute politique sectorielle. Un système éducatif ne peut être performant si les enfants souffrent de malnutrition ou d'infections parasitaires récurrentes affectant leurs fonctions cognitives. Au Sénégal, les orientations du Plan Sénégal Émergent, combinées aux objectifs d'atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle, font de la protection sociale en santé un levier de réduction des inégalités et de stimulation de la croissance locale. Pour la recherche de niveau supérieur, l'intérêt réside dans la modélisation des impacts des dépenses de santé sur la productivité agricole et industrielle, fournissant des outils d'aide à la décision pour optimiser le financement public de la protection sociale. Dès lors, la réflexion s'articule autour de l'interrogation suivante : comment les politiques publiques de santé en Afrique, face au défi d'une double transition épidémiologique et sous contrainte de ressources, peuvent-elles s'émanciper des approches purement curatives pour devenir le moteur structurel d'un développement humain et endogène durable ? Pour y répondre, notre analyse examinera d'abord les mécanismes économiques et les interactions théoriques qui lient la santé au développement, avant d'analyser les fractures structurelles et les défis macroéconomiques du secteur sanitaire, pour enfin dégager les perspectives critiques et les solutions de refondation des systèmes de soins adaptés aux réalités africaines.

I. MÉCANISMES ÉCONOMIQUES ET INTERACTIONS THÉORIQUES ENTRE SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT

La compréhension approfondie de la corrélation entre la santé et le développement exige de décortiquer les canaux de transmission par lesquels l'état biologique d'une population influence la performance macroéconomique d'une nation.

A. La santé comme composante majeure du Capital Humain et de la productivité

L'économie de la santé contemporaine appréhende le corps humain comme un stock de capital productif. Le modèle fondateur de Michael Grossman formalise l'idée que chaque individu naît avec un stock initial de santé qui s'amortit avec le temps, mais qui peut être accru par des investissements en soins, en nutrition et en hygiène de vie. Au niveau microéconomique, un travailleur en bonne

santé présente des taux d'absentéisme plus faibles, une endurance physique supérieure et une concentration intellectuelle accrue. En zone rurale sénégalaise, par exemple, les épisodes palustres coïncident fréquemment avec l'hivernage, période critique des travaux agricoles. La morbidité liée au paludisme engendre une perte directe de jours de travail, réduisant les rendements des cultures de subsistance et de rente, ce qui précipite les ménages dans une trappe à pauvreté saisonnière. L'investissement dans les moustiquaires imprégnées ou la chimioprévention du paludisme saisonnier n'est donc pas une simple dépense sociale, mais un intrant agricole direct.

Au niveau macroéconomique, l'amélioration de l'état de santé général élève l'espérance de vie au sein de la population. Cette extension de l'horizon temporel individuel modifie profondément les comportements d'épargne et d'investissement à long terme. Un citoyen qui anticipe une vie longue est incité à épargner pour ses vieux jours, fournissant ainsi au système financier national les capitaux stables nécessaires au financement des infrastructures de base. De surcroît, des parents assurés de la survie de leurs enfants investissent davantage dans la qualité de leur éducation plutôt que dans la quantité des naissances, favorisant le passage d'une économie de main-d'œuvre non qualifiée à une économie de la connaissance. La santé agit ainsi comme un catalyseur du progrès technique endogène en maximisant les rendements de l'éducation.

B. Le dividende démographique et la théorie des capacités d'Amartya Sen

L'interaction entre santé et développement trouve son expression la plus dynamique dans le concept de dividende démographique, articulé avec l'approche par les capacités. La transition démographique, caractérisée par le passage d'un régime de forte mortalité et forte natalité à un régime de faible mortalité et faible natalité, commence invariablement par une baisse de la mortalité infantile grâce aux progrès de la médecine préventive, comme la vaccination, l'hygiène et la réhydratation. Ce recul de la mortalité entraîne, après un temps de latence, une baisse de la fécondité. Il en résulte une modification de la structure par âges de la population : la part des actifs devient temporairement bien supérieure à celle des dépendants, constitués par les enfants et les personnes âgées. Si cette masse de jeunes actifs est saine et bien formée, elle génère une opportunité unique d'accélération de la croissance économique, un dividende démographique que les pays est-asiatiques ont su exploiter au vingtième siècle et que l'Afrique subsaharienne cherche actuellement à capter à travers ses politiques d'émergence.

Sur le plan philosophique et méthodologique, l'approche d'Amartya Sen révolutionne cette vision en extirpant la santé de sa seule utilité productive ou mercantile. Pour Sen, la maladie, l'infirmité ou la malnutrition précoce constituent des privations de capacités, c'est-à-dire des barrières fondamentales qui empêchent l'être humain d'accomplir son potentiel et d'exercer sa liberté de choix. Un enfant malnutri subissant un retard de croissance souffre d'une injustice cognitive et physique irréversible qui limitera toute son existence. La santé est alors définie comme la liberté première : elle est la condition anthropologique sans laquelle aucune autre liberté politique ou citoyenne ne peut s'exercer valablement. Le développement se mesure dès lors non pas au volume de biens produits ou au niveau du PIB, mais au degré d'affranchissement des individus face aux souffrances évitables et aux fatalités biologiques.

Cette conceptualisation de la santé comme liberté et capital productif se heurte toutefois aux réalités matérielles et institutionnelles des pays en développement, dont les systèmes de soins subissent de lourdes crises structurelles qu'il convient d'analyser.

II. FRACTURES STRUCTURELLES, CRISES SYSTÉMIQUES ET DÉFIS MACROÉCONOMIQUES DES SYSTÈMES DE SANTÉ

Malgré la clarté de ces liens théoriques, les infrastructures sanitaires des pays en développement traversent des crises profondes qui limitent leur contribution à l'émergence économique et sociale.

A. Le sous-financement chronique et la fuite des cerveaux médicaux

La première limite structurelle des systèmes de santé africains réside dans l'asymétrie de leur modèle de financement et la fragilité de leurs ressources humaines qualifiées. En 2001, les États membres de l'Union africaine ont signé la Déclaration d'Abuja, s'engageant à allouer au moins 15 % de leur budget annuel au secteur de la santé. Plus de deux décennies plus tard, la majorité des signataires, y compris le Sénégal, peinent à atteindre régulièrement ce seuil normatif en raison des pressions exercées par le service de la dette et d'autres priorités régaliennes. Ce sous-financement public récurrent se traduit par un reste à charge catastrophique pour les ménages. Le paiement direct des soins au guichet des hôpitaux, en l'absence de mécanismes de tiers-payant généralisés, agit comme une barrière d'exclusion majeure et constitue une cause première d'appauvrissement. Une maladie grave au sein d'une famille vulnérable force souvent à la vente des actifs productifs, transformant un choc sanitaire aigu en une détresse économique durable.

À cette crise financière s'ajoute la crise de la fuite des cerveaux médicaux, connue sous le terme de brain drain, qui fragilise l'offre de soins. Les facultés de médecine du Sud forment à grands frais des professionnels de santé hautement qualifiés qui, face à la faiblesse des plateaux techniques, à l'absence de perspectives de carrière stimulantes et à l'attractivité salariale des pays du Nord, émigrent massivement. Ce transfert inversé de richesses intellectuelles appauvrit les structures sanitaires locales, privant les populations des compétences nécessaires pour traiter les pathologies complexes et obligeant les États à recourir à des évacuations sanitaires extérieures coûteuses pour leurs élites, au détriment de l'équité républicaine. Les causes de cette émigration sont systémiques, liées à l'indigence des conditions de travail, tandis que ses conséquences aggravent la fracture sanitaire mondiale.

B. Le fardeau épidémiologique double et les risques technologiques

Les pays du Sud font face à une complexification inédite de leur tableau sanitaire, caractérisée par une superposition complexe des crises et des pathologies. Le premier défi majeur est la transition épidémiologique inachevée. Alors que les pays occidentaux ont largement maîtrisé les maladies infectieuses avant de voir émerger les pathologies de la sédentarité, l'Afrique subit de plein fouet le télescopage de deux époques épidémiologiques distinctes. D'un côté, les pathologies infectieuses, parasitaires et nutritionnelles continuent de sévir, alimentées par les déficits d'assainissement et l'insécurité alimentaire. De l'autre côté, les maladies chroniques non transmissibles connaissent une croissance exponentielle, portée par les mutations nutritionnelles en milieu urbain et le vieillissement de la population. Les systèmes de soins, initialement calibrés pour des réponses aiguës et de courte durée, s'avèrent inadaptés pour la prise en charge au long cours que nécessitent le diabète, l'insuffisance rénale ou l'hypertension artérielle.

Le second défi réside dans les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et les risques contrefactuels qui en découlent. L'Afrique subsaharienne dépend de l'extérieur pour près de 95 % de ses besoins en produits médicaux, ce qui la place dans une situation de dépendance géopolitique critique, comme l'a révélé l'accès inéquitable aux vaccins lors des crises sanitaires mondiales. Cette dépendance nourrit le fléau des faux médicaments et des produits de qualité inférieure ou falsifiés. Le marché informel du médicament, alimenté par la porosité des frontières et la faiblesse des agences nationales de régulation pharmaceutique, représente un risque sanitaire majeur. L'usage d'antibiotiques sous-dosés ou de molécules contrefaites entraîne des échecs

thérapeutiques dramatiques et accélère le phénomène de résistance antimicrobienne, menaçant l'efficacité future des traitements à l'échelle continentale.

Face à ces défis macroéconomiques et épidémiologiques, les réponses politiques doivent s'ancrer dans des réformes profondes combinant innovation technologique, souveraineté thérapeutique et équité sociale.

III. PERSPECTIVES CRITIQUES, RÉALITÉS SÉNÉGALAISES ET CHANTIERS DE REFONDATION SANITAIRE

La sortie de ces crises systémiques impose de repenser l'architecture des politiques publiques de santé en s'appuyant sur les innovations locales, la décentralisation des infrastructures et la souveraineté thérapeutique.

A. Analyse fine des politiques de santé au Sénégal

Le Sénégal présente un profil sanitaire contrasté, mêlant des succès programmatiques reconnus à l'échelle internationale et des disparités structurelles persistantes. Le pays a fait preuve d'une efficacité remarquable dans la gestion de crises épidémiologiques majeures. Lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 en Afrique de l'Ouest, l'isolement ultra-rapide du cas importé à Dakar et le déploiement d'un système de traçage rigoureux ont permis d'éviter la propagation du virus, érigeant le Sénégal en modèle de sécurité sanitaire. De même, la riposte contre la pandémie de Covid-19, portée par l'expertise scientifique de l'Institut Pasteur de Dakar et la réactivité du Centre des opérations d'urgence sanitaire, a démontré la qualité de sa recherche médicale d'élite. Dans le domaine de la lutte contre le paludisme, le Programme National de Lutte contre le Paludisme a obtenu des résultats probants grâce à la distribution universelle de moustiquaires et à l'introduction des tests de diagnostic rapide à l'échelle communautaire.

Cependant, ces succès réels et documentés masquent une profonde fracture géographique et sociale à l'intérieur du pays. La carte sanitaire du Sénégal révèle une forte macrocéphalie médicale : l'essentiel des infrastructures de pointe, des spécialistes de haut niveau et des équipements lourds est concentré dans la région de Dakar. Les régions périphériques, notamment l'Est et le Sud du pays, souffrent d'un déficit chronique en personnel qualifié, les gynécologues ou chirurgiens refusant fréquemment les affectations à l'intérieur du pays en raison de l'isolement des terroirs et du manque d'incitations financières ou de commodités de carrière. Cette situation engendre des taux de mortalité maternelle et néonatale anormalement élevés dans les zones rurales, contredisant le principe républicain d'équité territoriale et ralentissant le rythme global du développement humain.

B. Chantiers de refondation et solutions stratégiques

La transformation de la santé en un levier pérenne de développement humain exige la mise en œuvre de trois chantiers prioritaires et urgents. Le premier chantier est l'opérationnalisation d'une véritable souveraineté pharmaceutique et biotechnologique à l'échelle continentale et nationale. Pour rompre la dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, le Sénégal doit accélérer le développement de pôles de production locale de médicaments essentiels et de vaccins. Le projet Madiba, porté par l'Institut Pasteur de Dakar pour la fabrication de vaccins contre la fièvre jaune et d'autres pathologies endémiques, constitue la voie à suivre. Cette industrialisation pharmaceutique exige la création de cadres réglementaires stricts, alignés sur les standards de l'Organisation mondiale de la Santé, et un soutien financier public aux laboratoires nationaux pour stimuler la recherche-développement endogène.

Le deuxième chantier repose sur la refondation du financement de la protection sociale à travers la Couverture Sanitaire Universelle. L'expérience des Mutuelles de Santé Communautaires au Sénégal a

montré ses limites en raison du caractère volontaire des adhésions et de la faiblesse des capacités contributives du secteur informel et du monde rural. La solution réside dans le passage à un financement basé sur la solidarité nationale et la fiscalité affectée. Il s'agit de capter des ressources innovantes – par des taxes sur les produits tabagiques, les boissons sucrées, les transactions électroniques ou les communications téléphoniques – pour alimenter un Fonds National de Financement de la Santé. Ce fonds doit garantir la gratuité universelle des soins de base et la prise en charge des pathologies lourdes, protégeant définitivement les ménages contre le risque de catastrophe financière.

Le troisième chantier impose la valorisation institutionnelle de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles, intégrée dans une approche communautaire globale. Plus de 80 % des populations africaines ont recours en première intention aux tradipraticiens en raison de leur proximité culturelle et financière. L'enjeu n'est pas d'opposer cette médecine à la biomédecine occidentale, mais de créer des passerelles scientifiques réelles. Cela implique de mener des recherches pharmacologiques poussées sur les plantes médicinales locales au sein des universités sénégalaises pour isoler les principes actifs, standardiser les dosages et valider l'innocuité des remèdes traditionnels. Cette collaboration rigoureuse permet de bâtir un système de santé pluraliste, ancré dans les réalités socioculturelles africaines, et de développer des soins de proximité résilients et accessibles à tous.

CONCLUSION

Ce cours magistral a permis de démontrer que la relation entre la santé et le développement n'est pas un rapport de simple corrélation linéaire passive, mais une interaction dynamique et causale indispensable. Nous avons établi que la santé constitue une composante première du capital humain, agissant directement sur la productivité microéconomique et l'épargne macroéconomique, tout en conditionnant la captation du dividende démographique. Nous avons analysé les fractures profondes qui entravent les systèmes de soins du Sud, notamment le sous-financement chronique, la fuite des compétences médicales vers les pays industrialisés, et le défi colossal d'un fardeau épidémiologique double qui superpose les urgences infectieuses aux pathologies chroniques non transmissibles. Enfin, l'examen des réalités sénégalaises a mis en lumière le contraste saisissant entre une expertise médicale d'élite capable de gérer des urgences sanitaires complexes et une inégalité géographique persistante dans la distribution de l'offre de soins.

En dernière analyse, concevoir la santé comme un moteur de développement au vingt-et-unième siècle impose de rompre définitivement avec la dépendance épistémologique et matérielle vis-à-vis des modèles sanitaires occidentaux, caractérisés par une approche hyper-spécialisée et curative extrêmement coûteuse. L'avenir des politiques publiques en Afrique réside dans la construction de systèmes de santé souverains, centrés sur la prévention, la protection sociale solidaire et la valorisation scientifique des ressources endogènes de la biodiversité continentale. En articulant la recherche biotechnologique de pointe avec les savoirs thérapeutiques traditionnels et une gouvernance décentralisée, le continent africain a l'opportunité de réinventer un modèle de bien-être global durable. C'est à cette condition que la santé deviendra la liberté réelle théorisée par Amartya Sen, permettant de libérer l'énergie créatrice et productive des populations pour porter l'émergence économique du continent.